

권 고

1. 제 목 : 다학제통합진료에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 암환자를 대상으로 여러 임상과 전문의가 다양한 의견을 모아 정확한 진단 및 병기에 맞는 정확한 치료 제공을 위해 다학제 통합진료를 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「보건복지부 고시」 제2018-269호 다학제통합진료료 산정기준에 따르면 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 의한 산정특례 대상 중 미등록암환자, 중증질환자, 희귀난치성질환자 및 결핵질환에 해당하는 환자로 외래 및 입원 진료 시 [표 1]과 같은 기준을 충족하는 경우 다학제통합진료료를 산정할 수 있도록 정하고 있습니다.

[표 1] 다학제 통합진료료 산정기준

가. 산정기준

- 1) 다학제통합진료료는 상근하는 서로 다른 전문과목[또는 세부 전문과목(분야)] 전문의가 동시에 대면진료에 참여하여야 함
- 2) 다학제통합진료 시간 및 장소, 참여의사 성명 및 서명, 치료방침 및 결정사유, 설명한 내용 등을 진료기록부에 기록하여야 함

나. 선정회수

- 질환별 환자 당 3회 이내로 인정함. 다만, 소견서를 참조하여 2회 이내로 추가 인정할 수 있음.

따라서 여러 임상과 전문의의 종합적인 의견이 필요한 대상자 발생 시 해당 환자 대면진료를 통해 병기에 맞는 치료계획 설명 및 치료방침을 결정하고 통합진료 사항에 대한 적정 진료비를 청구할 수 있도록 해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

2018.3.19. 제11차 암센터운영위원회 안건 ‘암센터 다학제통합진료 운영계획(안)’을 살펴보면 암종별 다학제통합진료 전문의 구성, 다학제통합진료실 시설공간, 다학제통합진료 진료지원 간호사, 다학제통합진료 EMR프로그램 개발사항 등을 검토하고 다학제통합진료 운영으로 ‘국가유공자의 특화된 암 진료서비스 제공’ 및 ‘다학제통합진료료 수익 발생’을 기대효과로 하여 [표 1]과 같이 장기별 암센터 다학제통합진료 운영계획을 수립하였습니다.

[표 1] 장기별 암센터 다학제통합진료 운영계획(안)

구 분	다학제통합진료 의료진구성	운 영 방 법
대 장 암 센 터	센터장(부장) 등 외과, 소화기내과, 혈액종양내과, 방사선종양학과, 영상의학과, 병리과, 핵의학과 전문의 총 14명	·운영요일 : 매월 마지막주 수요일 ·운영시간 : 오후4시~오후4시30분 ·운영구성 : 3~7명의 의료진으로 대장암 통합진료
위 암 센 터	센터장(부장) 등 외과, 혈액종양내과, 방사선종양학과, 영상의학과, 병리과, 핵의학과 전문의 총 12명	·'18.7월 센터장 연수 복귀후 일정 조정 ·운영구성 : 7명의 의료진으로 위암 통합진료
폐 암 센 터	센터장(부장) 등 혈액종양내과, 호흡기내과, 흉부외과, 방사선종양학과, 영상의학과, 핵의학과, 병리과 전문의 총 15명	·운영요일 : 수요일 격주 ·운영시간 : 오후12시30분~오후1시30분 ·운영구성 : 3~9명의 의료진으로 폐암 통합진료
비뇨기암센터	센터장(부장) 등 비뇨의학과, 혈액종양내과, 방사선종양학과, 병리과, 핵의학과, 영상의학과 전문의 총 11명	·운영요일 : 매월 첫째주 수요일 ·운영시간 : 오후12시30~오후4시30분 ·운영구성 : 3~7명의 의료진으로 대장암 통합진료
혈 액 암 및 골수이식센터	센터장(부장) 등 방사선종양학과, 진단검사의학과, 핵의학과 전문의 총 5명	·운영요일 : 화요일 ·운영시간 : 오후4시~오후5시 ·운영구성 : 4명의 의료진으로 혈액암 통합진료
유 방 암 센 터	센터장(부장) 등 외과, 혈액종양내과, 방사선종양학과, 영상의학과, 병리과, 핵의학과 전문의 총 7명	·case 발생시 개별적으로 연락한 후 일정조정 ·운영구성 : 6명의 의료진으로 위암 통합진료
골 연 부 육 종 센 터	센터장(부장) 등 정형외과, 혈액종양내과, 방사선종양학과, 영상의학과, 병리과, 핵의학과 전문의 총 10명	·운영요일 : 목요일 ·운영시간 : 오후4시30분~오후5시30분 ·운영구성 : 6명의 의료진으로 골연부육종 통합진료

그런데 2018.10.~2020.06. ○○보훈병원에서 다학제통합진료 운영실태를 확인한 결과, 위 기간동안 [표 2]와 같이 총 #건에 대해 다학제통합진료를 실시하고 대장암센터 #건, 혈액암 및 골수이식센터 #건을 시행하였으며, 그 외 폐암센터 등 5개 센터는 운영하기로 계획은 하였으나 통합진료 사례가 없습니다.

[표 2] 다학제통합진료 실적

○ 산출기간 : 2018.10.01.~2020.06.30.

(단위 : 원)

센터구분	국사비	구분	처방일자	수가명칭	금 액
대 장 암 센 터	국비	외래	2018.10.31.	다학제통합진료료-참여의사수 5인	###,###
	사비	외래	2018.11.28.	다학제통합진료료-참여의사수 5인	###,###
	국비	외래	2019.03.20.	다학제통합진료료-참여의사수 5인	###,###
혈 액 암 및 골수이식센터	사비	입원	2019.05.28.	다학제통합진료료-참여의사수 4인	###,###
합 계					###,###

4. 관계기관 의견

○○보훈병원 암센터에서는 여러 진료과 전문의의 외래 및 수술 시간이 주중에 정해져 있고, 환자는 비정기적으로 내원하고 있으며, 일부 진료과는 전문의가 1~2명에 불과하여 대면진료를 통한 다학제진료가 사실상 용이하지 않다고 하였으나, [표 1]의 장기별 암센터 다학제통합진료 운영계획에 따라 4시 이후 등 환자의 진료가 적은 시간대를 활용하고 비교적 환자와 일정 조정하기 쉬운 입원환자까지 폭넓게 운영을 한다면 다학제통합진료를 좀 더 활성화 할 수 있을 것입니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- 자체적으로 계획한 ‘장기별 암센터 다학제통합진료 운영계획’에 따라 환자 진료가 적은 시간대 활용하여 다학제통합진료가 좀 더 활성화 할 수 있도록 바랍니다.(권고)